



TATA LAKSANA IBU HAMIL DAN BALITA BERMASALAH GIZI MELALUI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) LOKAL TAHUN 2026

Jakarta, 4-6 Februari 2026

**Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga
Kementerian Kesehatan RI**

Tahun 2026



TATA LAKSANA IBU HAMIL BERMASALAH GIZI

Prinsip Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil



SASARAN:

Ibu Hamil KEK (IMT $<18,5$ kg/m² saat pra hamil/TM 1 <12 mgg); dan/atau

Ibu Hamil Risiko KEK (LiLA $<23,5$ cm)



Berupa makanan siap santap, dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan – yang mengandung protein hewani dengan memperhatikan gizi seimbang, **membatasi penggunaan gula, garam dan lemak tinggi (GGL).**



- Berupa **tambahan asupan** dan **bukan pengganti makanan utama.**
- Pemberian makanan tambahan **disertai edukasi** (demonstrasi/penyuluhan/konseling).
- Mengedepankan prinsip **pemberdayaan masyarakat.**



Lama waktu pemberian makanan tambahan:

Makanan tambahan Ibu hamil diberikan selama **minimal 120 hari.**



Diberikan **setiap hari.**

Dalam 1 siklus menu dapat diberikan 1 kali makanan lengkap sebagai sarana edukasi isi piringku, selain itu diberikan dalam bentuk makanan selingan/kudapan padat gizi.

Catatan:

- Pelaksanaan PMT berbahan pangan lokal diutamakan menggunakan **bahan makanan yang terfortifikasi**, seperti garam, minyak goreng, tepung terigu, dll.
- Pada **daerah yang sudah melaksanakan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG)** bagi ibu hamil, **PMT berbahan pangan lokal bagi ibu hamil bermasalah gizi pada hari yang sama dengan MBG diberikan dalam bentuk makanan selingan/kudapan padat gizi.**

Standar Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal untuk Ibu Hamil

Komposisi Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dalam satu hari

Zat Gizi	Makanan Lengkap		Makanan Kudapan	
Energi	500 – 700 kkal		510 – 530 kkal	
Protein (gr)	18 – 23%	29 – 34 gram	18 – 23%	23 – 27 gram
Lemak (gr)	20 – 30%	14 – 24 gram	30 – 40%	19 – 23 gram

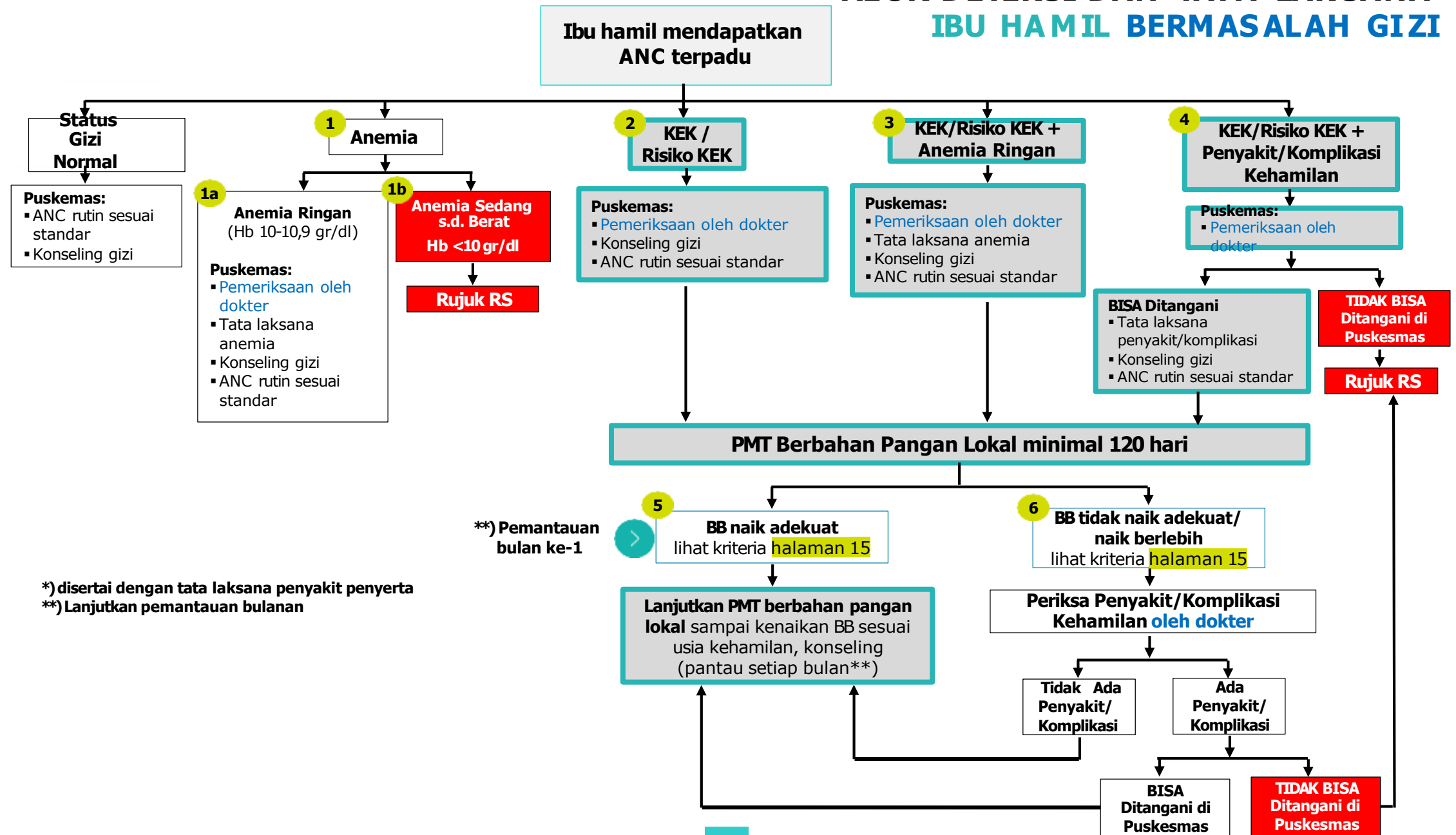


- Makanan padat gizi dan seimbang, yang terdiri dari sumber makanan pokok, sumber lauk pauk hewani dan nabati serta sayur dan buah.
- Bahan makanan sumber protein hewani mengacu pada lampiran (halaman 104).
- Standar porsi berat bahan makanan matang dapat mengacu **Pedoman Konversi Berat Matang-Mentah, Berat Dapat Dimakan dan Resep Makanan Siap Saji dan Jajanan** (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Contoh Standar Bahan Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Risiko KEK yang disiapkan untuk 1 kali makan (Makanan Kudapan/Makanan Lengkap)

Bahan Makanan	Makanan Kudapan		Makanan Lengkap	
	Berat (gram)	Ukuran Rumah Tangga (URT)	Berat (gram)	Ukuran Rumah Tangga (URT)
Makanan Pokok (beras)	40	½ gelas	75	½ gelas
Lauk hewani 1 (telur)	60	1 butir besar	Ikan 75 g/ ayam 60 g/ telur 60 g/ daging 60 g	1 ekor/ 1 potong besar/
Lauk hewani 2 (ayam/ikan/daging)	30 - 50	½ potong sedang		1 butir besar/ 1 potong besar
Lauk Nabati (kacang-kacangan/tempe/tahu)	25	3 sdm/ ½ potong sedang	50	2 potong sedang
Sayur	50	½ gelas ukuran 250 ml	100	1 gelas
Buah	60	1 buah ukuran sedang	100	1 buah ukuran besar/ 2 potong sedang
Minyak/lemak	5	1 sdt	5	1 sdt

ALUR DETEKSI DAN TATA LAKSANA IBU HAMIL BERMASALAH GIZI



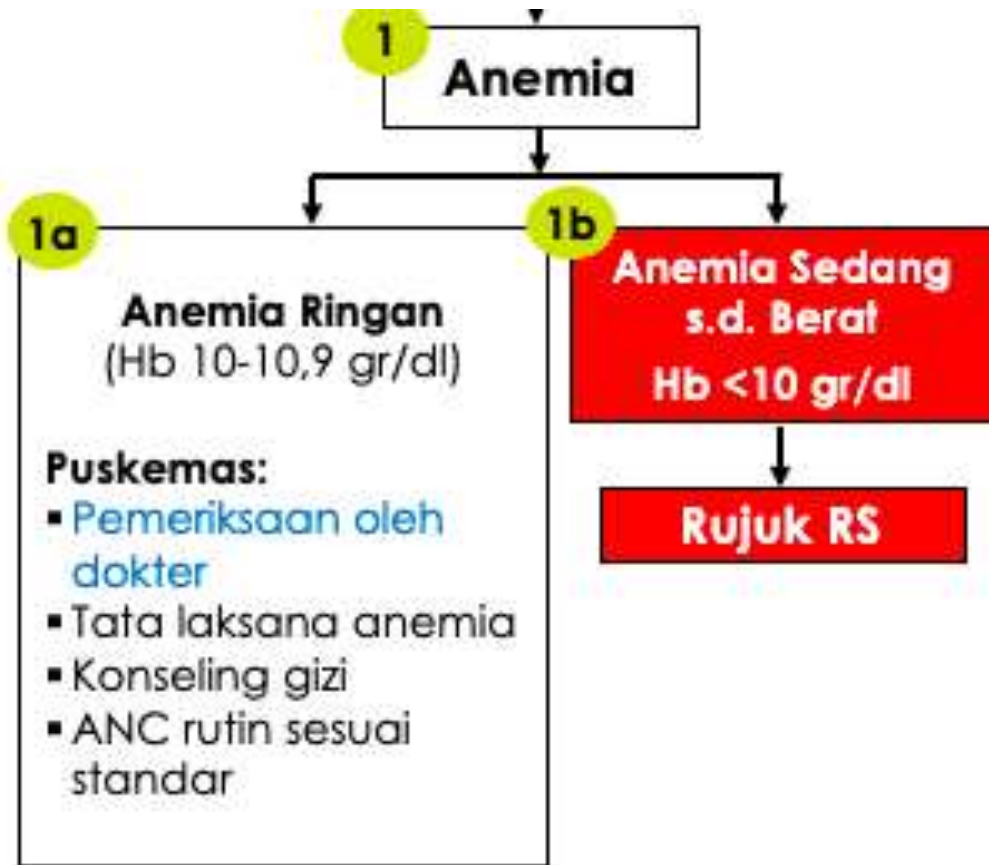
ALUR TATA LAKSANA IBU HAMIL ANEMIA

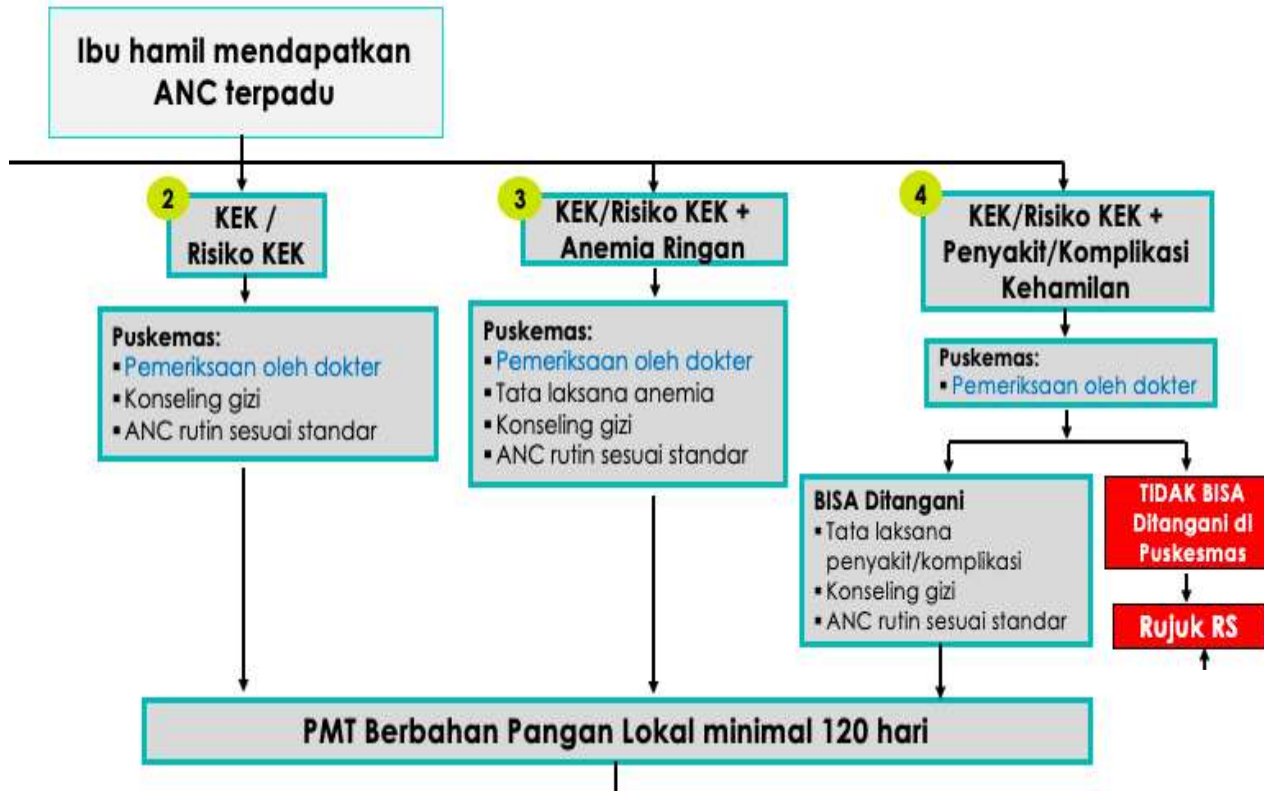
Setiap ibu hamil harus mendapatkan ANC terpadu. Setiap ANC dilakukan penapisan di Fasyankes untuk mendeteksi masalah gizi dan kesehatan pada ibu hamil. Jika hasil penapisan:

1 Anemia saja: **Pemeriksaan oleh dokter**, tata laksana anemia dan edukasi/konseling gizi.

- 1a Anemia ringan (Hb 10 – 10,9 gr/dl): tata laksana pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) 2 x 1/hari atau (1 MMS + 1 TTD)/hari.
- Pemantauan kadar Hb ibu hamil dilakukan setelah **4 minggu**.
 - **Jika Hb meningkat:** pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) 2 x 1/hari atau (1 MMS + 1 TTD)/hari dapat diteruskan hingga 4 minggu berikutnya.
 - **Jika Hb tetap/turun:** rujuk ke RS.

1b Anemia sedang s.d berat (< 10 gr/dl): rujuk ke RS.





Catatan:

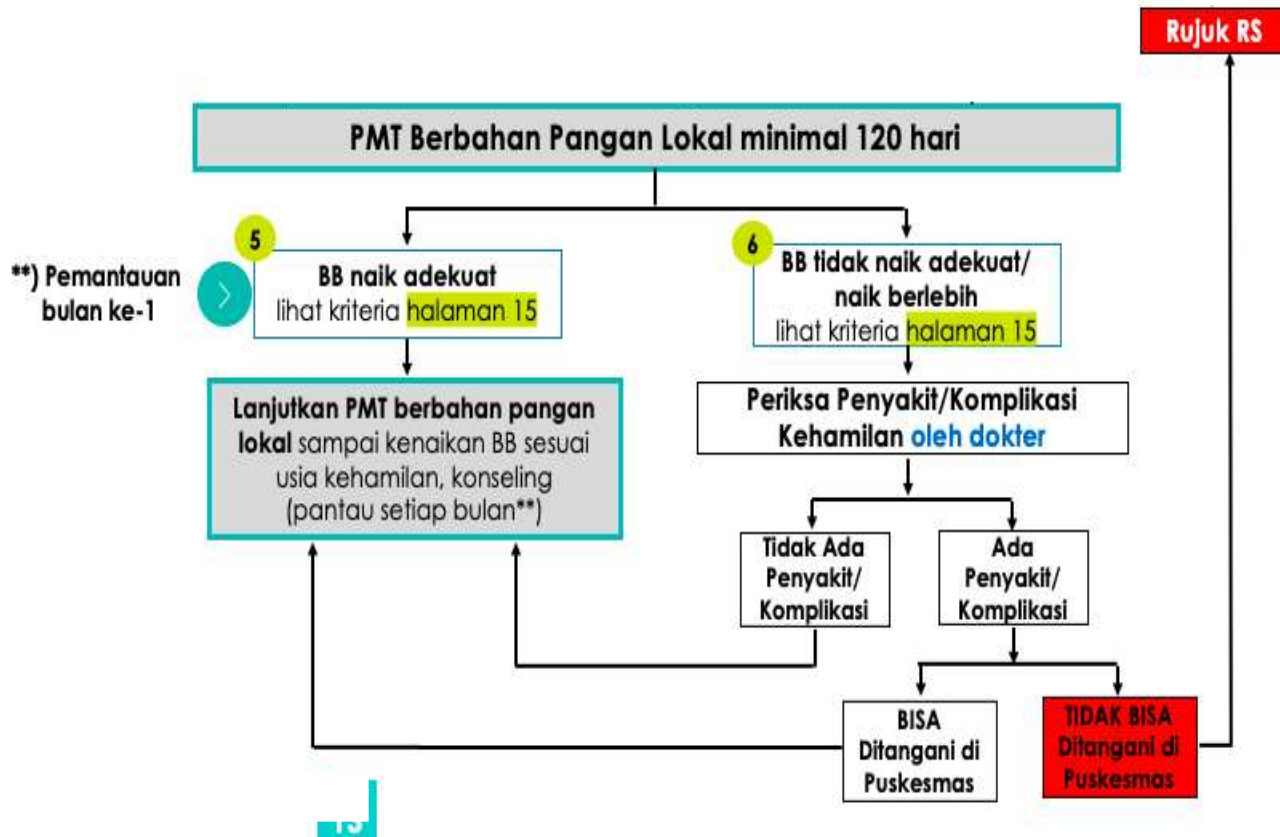
Gunakan data IMT dan/atau LiLA sasaran terbaru, setidaknya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan PMT berbahan pangan lokal.

ALUR TATA LAKSANA

IBU HAMIL KURANG ENERGI KRONIS (KEK) & RISIKO KEK

Setiap ibu hamil harus mendapatkan ANC terpadu. Setiap ANC dilakukan penapisan di Fasyankes untuk mendeteksi masalah gizi dan kesehatan pada ibu hamil. Jika hasil penapisan:

- 2 KEK/Risiko KEK saja: **Pemeriksaan oleh dokter, tata laksana dengan PMT** berbahan pangan lokal minimal selama 120 hari disertai edukasi/konseling gizi.
- 3 KEK/Risiko KEK + Anemia ringan: **Pemeriksaan oleh dokter, tata laksana dengan PMT** berbahan pangan lokal minimal selama 120 hari, tatalaksana anemia disertai edukasi/konseling gizi.
- 4 KEK/Risiko KEK + penyakit/komplikasi kehamilan: lakukan **pemeriksaan oleh dokter**. Apabila **BISA ditangani di puskesmas, tata laksana dengan PMT** berbahan pangan lokal minimal selama 120 hari, tatalaksana penyakit/komplikasi kehamilan, disertai edukasi/konseling gizi.
Rujuk ke RS jika tidak dapat ditangani di Puskesmas.



*) disertai dengan tata laksana penyakit penyerta
 **) Lanjutkan pemantauan bulanan

5 Jika **pada pemantauan bulan pertama BB naik adekuat**, kenaikan BB berdasarkan **tabel 1.1** (Halaman 16) atau **grafik peningkatan BB sesuai usia kehamilan** pada Buku KIA, **lanjutkan PMT berbahan pangan lokal**, disertai edukasi/konseling gizi dan **lakukan pemantauan rutin setiap bulan**.

6 Jika **pada pemantauan bulan pertama BB Tetap/BB Tidak Naik/BB Naik Tidak Sesuai Tabel atau Grafik: Periksa ada atau tidaknya penyakit/komplikasi kehamilan oleh Dokter**.

Jika hasil pemeriksaan:

- **Ada penyakit/komplikasi kehamilan yang tidak dapat ditangani** di Puskesmas: **rujuk ke RS**.
- **Ada penyakit/komplikasi kehamilan yang dapat ditangani** di Puskesmas: **lakukan tata laksana penyakit/komplikasi kehamilan**, **lanjutkan PMT berbahan pangan lokal** dan **lakukan pemantauan rutin setiap bulan**.
- **Tidak ada penyakit/komplikasi kehamilan**: **lanjutkan PMT berbahan pangan lokal** dan **lakukan pemantauan rutin setiap bulan**.

Dampak intervensi PMT berbahan pangan lokal dipantau melalui kenaikan berat badan yang disesuaikan dengan status gizi ibu sebelum hamil

Tabel 1.1 Pertambahan BB selama kehamilan direkomendasikan sesuai IMT¹ sebelum hamil—grafik tersedia di buku KIA

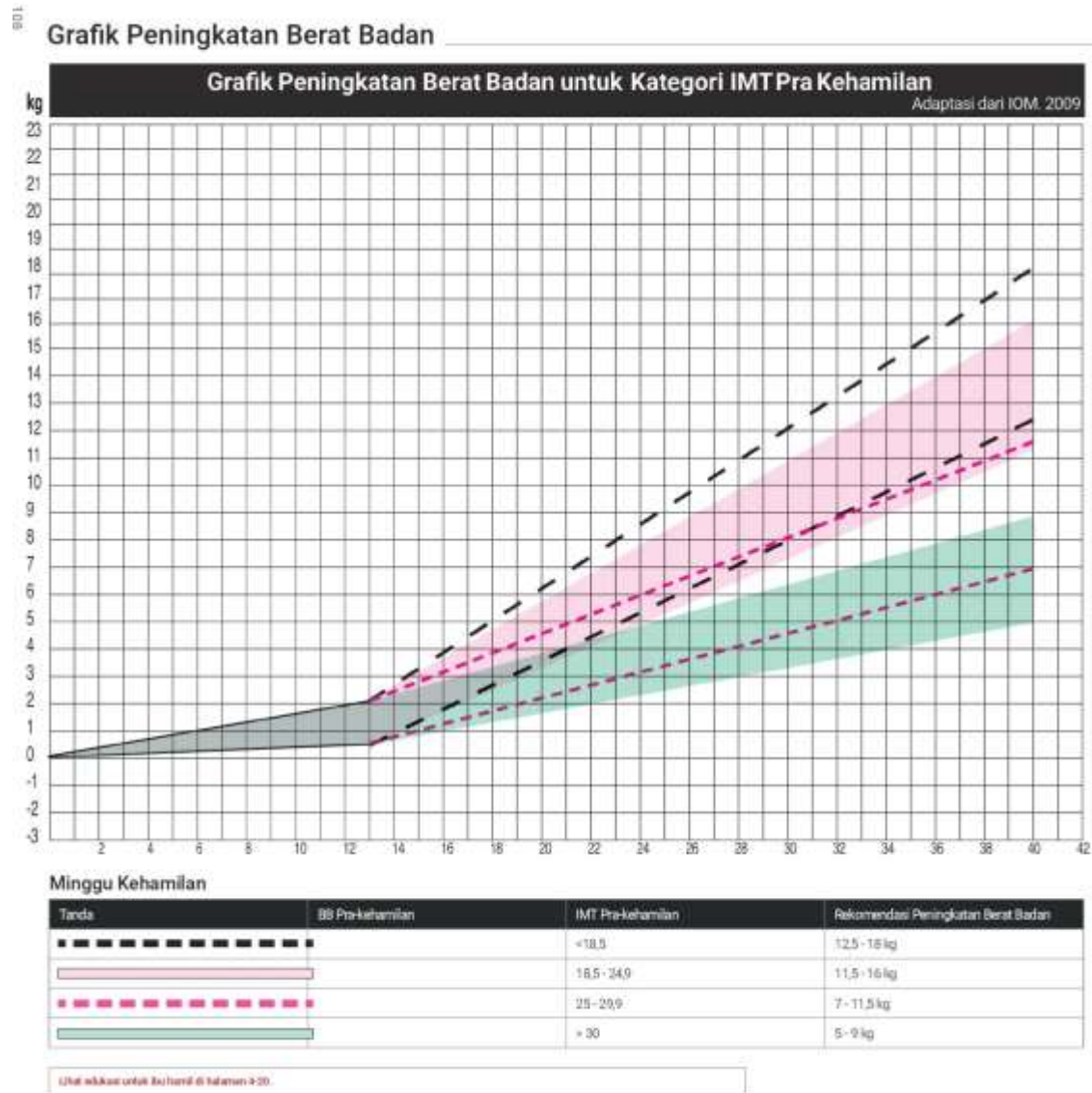
IMT ¹ sebelum hamil	Pertambahan BB pada Trimester 1	Pertambahan BB per minggu pada Trimester 2 dan Trimester 3	Pertambahan BB Total (Kehamilan Tunggal)	Pertambahan BB Total (Kehamilan Ganda)
Kurus ($<18.5 \text{ kg/m}^2$)	1 – 3 kg	0.5 kg	12.5 – 18 kg	
Normal ($18.5 - 24.9 \text{ kg/m}^2$)	1 – 3 kg	0.4 kg	11.5 – 16 kg	17 – 24 kg
Gemuk ($25.0 - 29.9 \text{ kg/m}^2$)	1 – 3 kg	0.3 kg	7 – 11.5 kg	14 – 23 kg
Obesitas ($>30.0 \text{ kg/m}^2$)	0.2 – 2 kg	0.2 kg	5 – 9 kg	11 – 19 kg

1. IMT = Indeks Massa Tubuh

Sumber: Modifikasi buku KIA tahun 2021 edisi 3 dan *Institute of Medicine (IOM)* tahun 2022

Grafik Peningkatan Berat Badan untuk Kategori IMT Pra Hamil

Tenaga Kesehatan melakukan pencatatan dan **plotting hasil penimbangan BB ibu hamil** (pemantauan bulanan) pada **Grafik Peningkatan Berat Badan di Buku KIA**



TATA LAKSANA BALITA BERMASALAH GIZI

Prinsip Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal bagi Balita



Berupa makanan siap santap, dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan - kaya protein hewani dengan memperhatikan gizi seimbang.

- Sumber protein hewani diharapkan dapat bersumber dari **2 jenis** bahan pangan hewani yang berbeda. Misalnya telur dan ikan, telur dan ayam, telur dan daging. Tujuannya untuk mendapatkan kandungan protein tinggi dan asam amino lengkap.
- Menghindari makanan dan minuman yang tinggi gula, mengandung pemanis buatan, pewarna, perasa, seperti susu dengan tambahan gula, berperisa dan kental manis.



- Berupa **tambahan asupan** dan **bukan pengganti makanan utama**.
- Pemberian makanan tambahan **disertai edukasi** (demonstrasi/penyuluhan/konseling).
- Mengedepankan prinsip **pemberdayaan masyarakat**.



Lama waktu pemberian makanan tambahan sesuai dengan masalah gizi balita:

- **Balita berat badan tidak naik (T)** diberikan makanan tambahan selama **14 hari**.
- **Balita berat badan kurang** diberikan makanan tambahan selama **28 hari**.
- **Balita gizi kurang** diberikan makanan tambahan selama **56 hari**.



Diberikan **setiap hari**.

Dalam 1 siklus menu dapat diberikan 1 kali makanan lengkap sebagai sarana edukasi isi piringku, selain itu diberikan dalam bentuk makanan selingan/kudapan padat gizi.



PMT berbahan pangan lokal pada anak 6-23 bulan, dilakukan sesuai **prinsip Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)** dan **tetap** melanjutkan pemberian ASI (*on demand*).

Catatan:

- Pelaksanaan PMT berbahan pangan lokal diutamakan menggunakan **bahan makanan yang terfortifikasi**, seperti garam, minyak goreng, tepung terigu, dll.
- Pada **daerah yang sudah melaksanakan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG)** bagi balita, PMT berbahan pangan lokal bagi balita bermasalah gizi pada hari yang sama dengan pemberian MBG disediakan dalam bentuk makanan selingan/kudapan padat gizi.

Standar Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal untuk Balita

Komposisi Makanan Tambahan bagi Balita (6-59 bulan) dalam satu hari

Zat Gizi	Usia Balita			
	6 – 8 bln	9 – 11 bln	12 – 23 bln	24 – 59 bln
Kalori (kkal)	175 – 200	175 – 200	225 – 275	300 – 450
Protein (gr)	3.5 – 8*	3.5 – 8*	4.5 – 11*	6 – 18*
Lemak (gr)	4.4 – 13	4.4 – 13	5.6 – 17.9	7.5 – 29.3

*Protein Energy Ratio (PER) sebesar 10% - 16%



- Makanan tambahan kaya protein hewani diutamakan **terdiri dari 2 (dua) jenis lauk hewani**.
- Bahan makanan sumber protein hewani mengacu pada lampiran (halaman 104).
- Standar porsi berat bahan makanan matang dapat mengacu **Pedoman Konversi Berat Matang-Mentah, Berat Dapat Dimakan dan Resep Makanan Siap Saji dan Jajanan** (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Contoh Standar Bahan Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal bagi Balita (6 – 59 bulan) yang disiapkan untuk 1 kali makan (makanan lengkap/kudapan)

Bahan Makanan	Berat (gram)	Ukuran Rumah Tangga (URT)
Makanan Pokok (beras)	50	½ gelas
Lauk hewani 1 (telur)	30	1 butir telur ayam ukuran kecil
Lauk hewani 2 (ayam/ikan/daging)	30	½ potong sedang ayam atau daging ½ ekor ikan ukuran sedang
Lauk nabati (kacang/tempe/tahu)	25	½ potong sedang
Sayur	30	1/3 gelas ukuran 250 ml
Buah	50	1 buah
Minyak/lemak	5	1 sdt

Catatan:

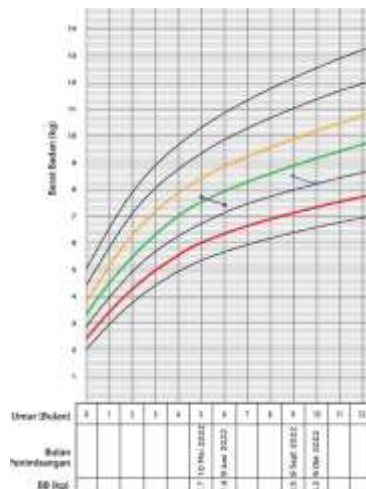
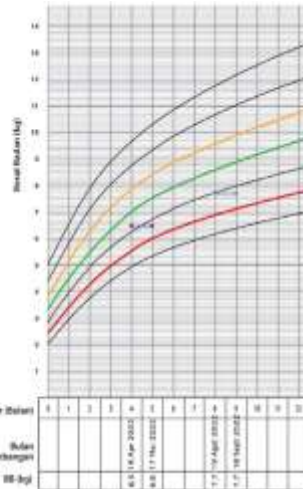
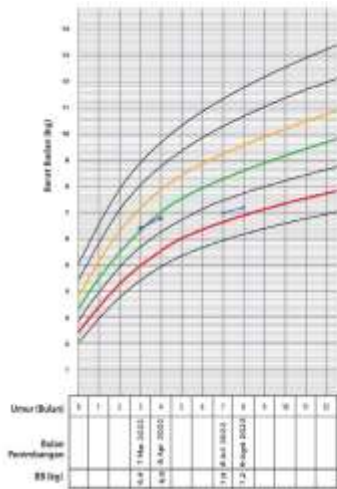
- Berupa tambahan asupan (30-50% dari kebutuhan total kalori harian) dan **bukan sebagai pengganti makanan utama**.
- Balita bermasalah gizi yang mempunyai riwayat **alergi**, mendapatkan tata laksana khusus dari tenaga kesehatan.

Sasaran PMT lokal: Balita Bermasalah Gizi

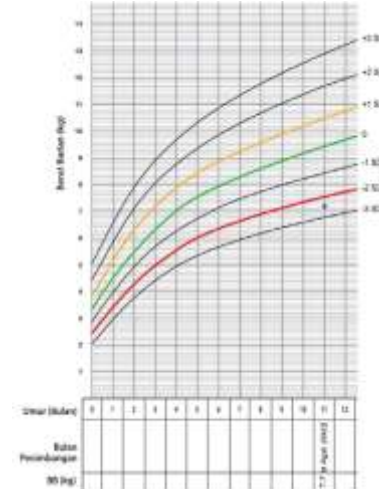
Balita bermasalah gizi adalah Balita yang mengalami **masalah/gangguan pertumbuhan**

Masalah/gangguan pertumbuhan dapat dilihat dari kecenderungan arah kurva pertumbuhan pada Kartu Menuju Sehat (KMS) dan penilaian status gizi oleh tenaga kesehatan melalui Grafik Pertumbuhan Anak (GPA).

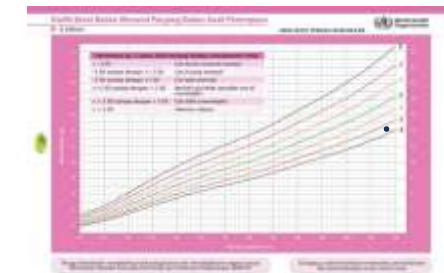
1. Balita Berat Badan Tidak Naik (T) BB Naik Tidak Cukup, BB Tetap atau BB Turun



2. Balita Berat Badan Kurang BB/U -3 SD s.d < -2 SD

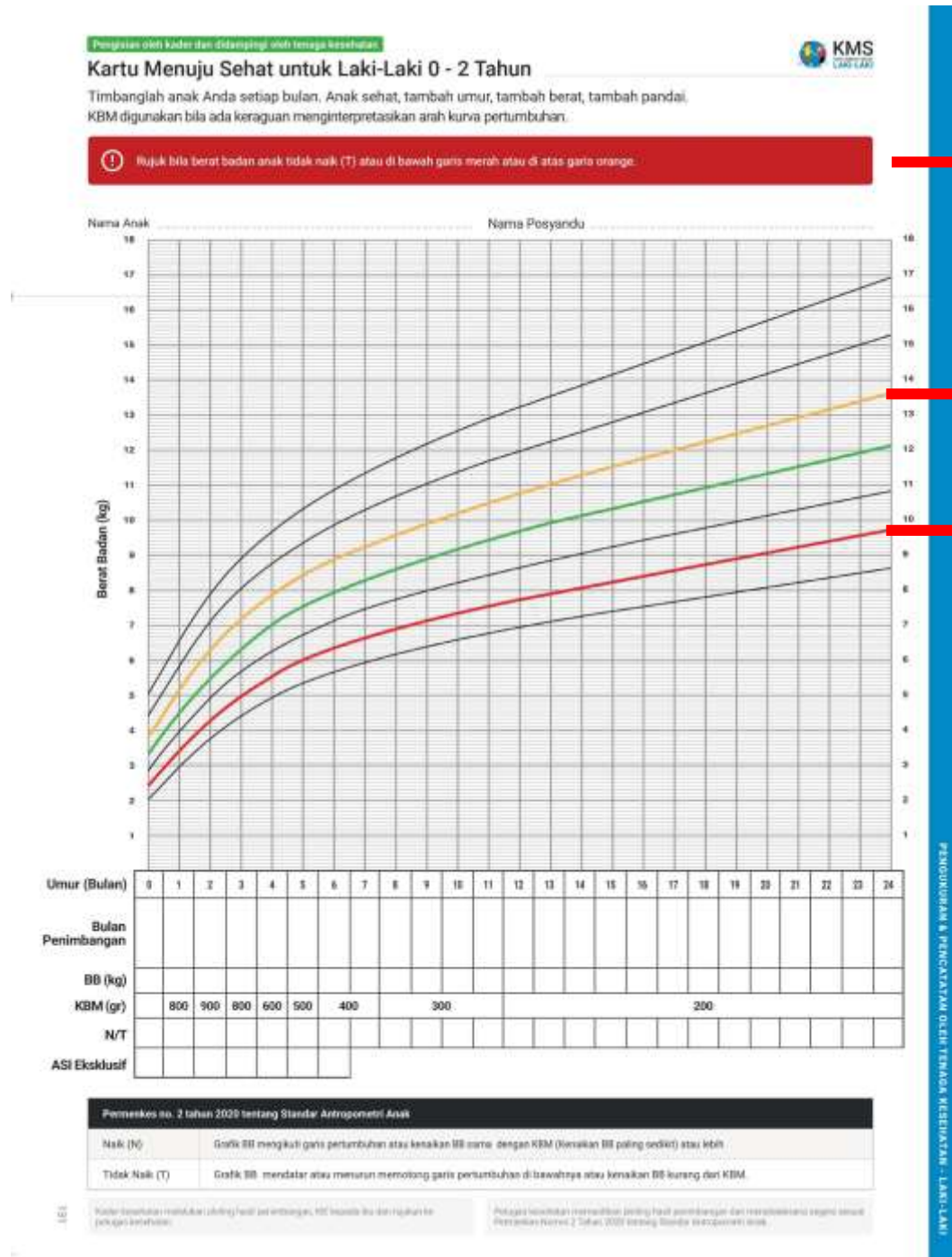


3. Balita Gizi Kurang



- Status gizi berdasarkan indeks BB/PB atau BB/TB berada pada z-skor -3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD;
- Lingkar lengan atas (LiLA) kurang dari 12,5 cm sampai 11,5 cm pada balita usia 6 – 59 bulan.

Penemuan awal sasaran dilakukan melalui Deteksi dini pemantauan pertumbuhan dengan KMS pada Buku KIA di Posyandu oleh kader



Tata Cara **Konfirmasi Status Gizi** oleh Tenaga Kesehatan

Kader merujuk kepada tenaga kesehatan jika menemukan Balita BB Tidak Naik (T), Balita Bawah Garis Merah (BGM) dan Risiko BB Lebih (diatas garis oranye). Selanjutnya tenaga kesehatan melakukan penimbangan dan pengukuran ulang serta konfirmasi status gizi dalam rangka penetapan sasaran PMT berbahan pangan lokal.

1. Periksa grafik BB/U

Hasil Konfirmasi BB/U	Status Gizi	Tata Laksana
- 2 SD s.d +1 SD	Berat Badan Normal	Jika BB Tidak Naik (T): Cek Red Flag/Penyakit Penyerta oleh dokter • Ada Red Flag/Penyakit Penyerta: Tata laksana Red Flag/Penyakit Penyerta • Tidak ada Red flag/Penyakit Penyerta: Tata laksana PMT Lokal
< - 2 SD	Berat Badan Kurang	Konfirmasi grafik BB/PB atau BB/TB Cek Red Flag/Penyakit Penyerta oleh dokter • Ada Red Flag/Penyakit Penyerta: Tata laksana Red Flag/Penyakit Penyerta • Tidak ada Red flag/Penyakit Penyerta: Tata laksana PMT Lokal

2. Periksa grafik BB/PB atau BB/TB

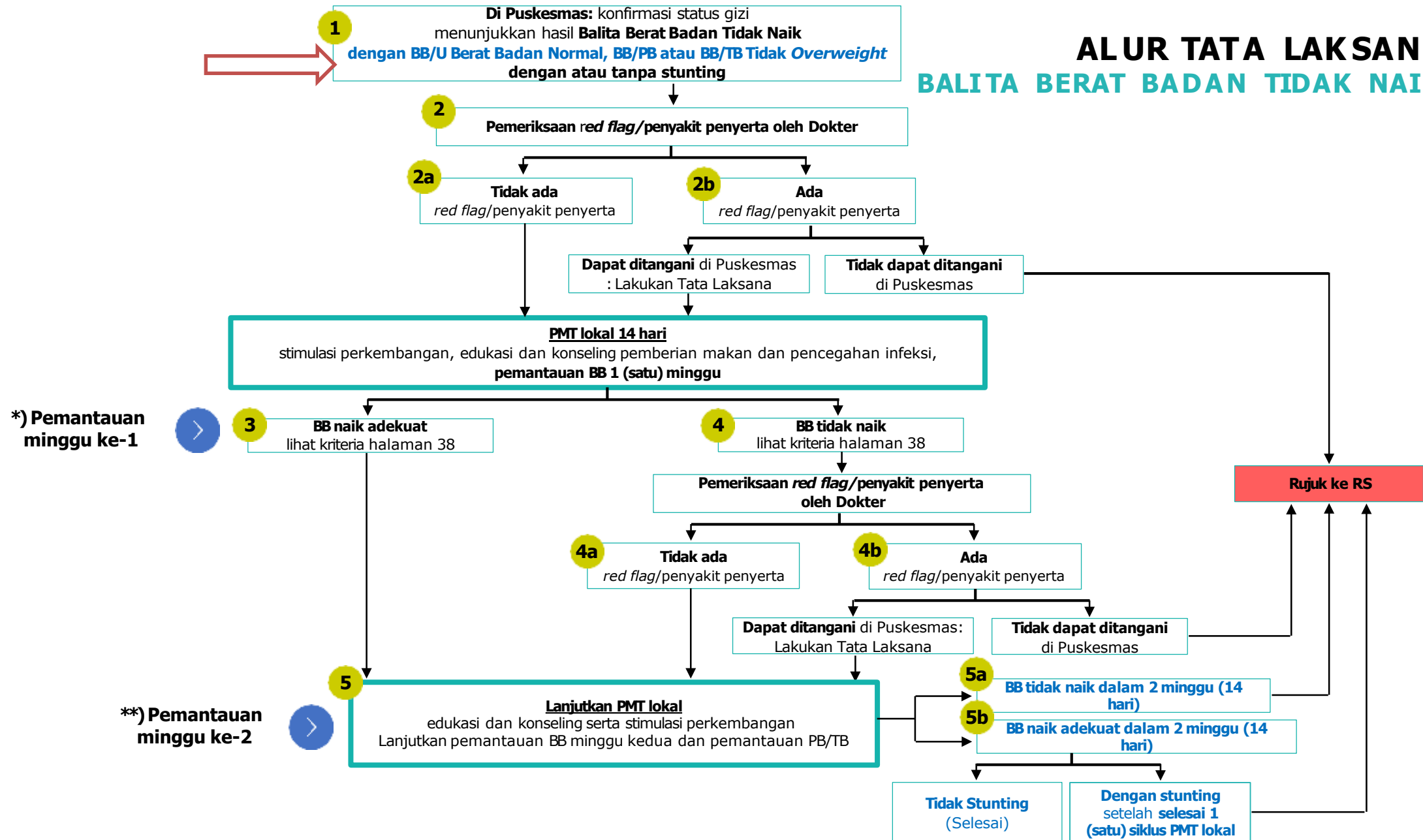
Hasil Konfirmasi BB/PB atau BB/TB	Status Gizi	Tata Laksana
-2 SD s.d +1 SD	Gizi Baik	Konfirmasi grafik BB/U
-3 SD s.d < -2 SD	Gizi Kurang	Cek Red Flag/Penyakit Penyerta oleh dokter • Ada Red Flag/Penyakit Penyerta: Tata laksana Red Flag/Penyakit Penyerta • Tidak ada Red Flag/Penyakit Penyerta: Tata laksana PMT Lokal

3. Periksa grafik PB/U atau TB/U

< - 3 SD	Gizi Buruk	Tata Laksana Gizi Buruk
Hasil Konfirmasi PB/U atau TB/U	Status Gizi	Tata Laksana
-2 SD s.d +3 SD	Normal	Periksa grafik BB/PB atau BB/TB
< -2 SD	Pendek/Sangat Pendek (stunting)	Tata Laksana Stunting dengan rujuk ke RS. Bagi balita stunting bermasalah gizi akut, rujukan dilakukan setelah selesai 1 (satu) siklus PMT lokal.

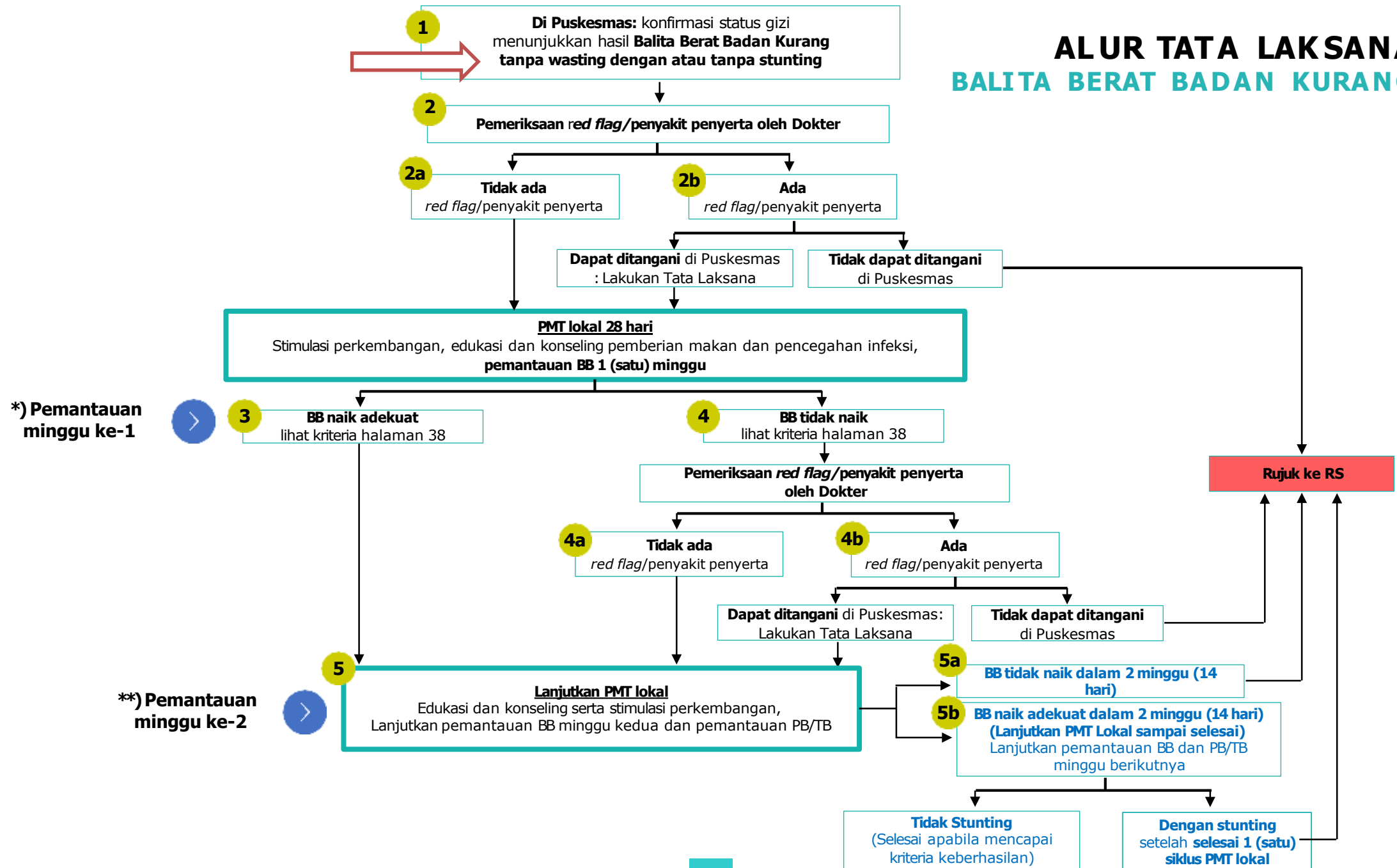
Interpretasi hasil penilaian status gizi balita untuk penetapan sasaran dapat dilihat pada lampiran 2.

ALUR TATA LAKSANA BALITA BERAT BADAN TIDAK NAIK

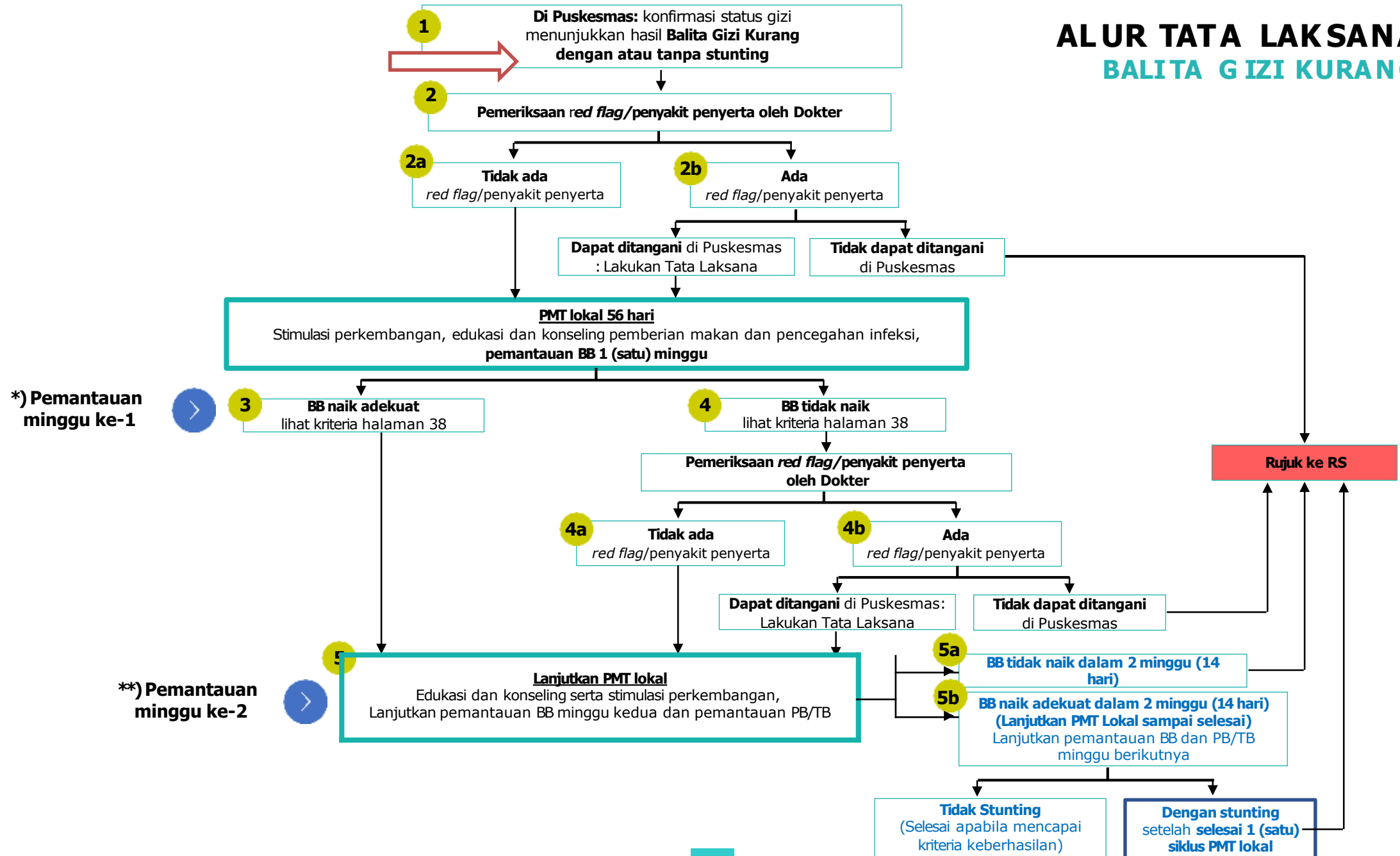


Balita berat badan tidak naik dengan Risiko BB Lebih dan *Overweight* tidak mendapatkan PMT lokal

ALUR TATA LAKSANA BALITA BERAT BADAN KURANG



ALUR TATA LAKSANA BALITA GIZI KURANG



Dampak intervensi PMT lokal dipantau melalui kenaikan berat badan

Kriteria keberhasilan

Berat badan tidak naik:



Berat badan naik adekuat mengikuti garis pertumbuhan normal pada KMS

BB Kurang:



Indeks BB/U sudah BB Normal (-2 SD s.d +1 SD) pada grafik pertumbuhan Berat Badan menurut Usia

Gizi Kurang:



Indeks BB/PB atau BB/TB sudah Gizi Baik (-2 SD s.d +1 SD) pada grafik pertumbuhan Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan

Catatan:

- PMT lokal dapat **tetap** diberikan sampai Balita mencapai kriteria keberhasilan.
- PMT lokal dapat tetap diberikan dengan memastikan **komitmen** baik dari orang tua/pengasuh.

Penjelasan

- **Kriteria keberhasilan** yaitu jika balita sudah keluar dari definisi operasional berat badan tidak naik, berat badan kurang, dan gizi kurang (lihat kriteria di samping).
- Jika **hasil konfirmasi pengukuran antropometri dan penilaian status gizi, Balita belum memenuhi kriteria keberhasilan** (lihat kriteria di samping), maka dilakukan **evaluasi ulang penyebabnya** (asupan gizi dan **red flag**/penyakit penyerta).
- Jika ada **red flag**/penyakit penyerta yang tidak dapat ditangani di Puskesmas, maka balita wajib rujuk ke RS.

Kenaikan BB adekuat

- Lakukan **plotting pada KMS**, lakukan penilaian kesesuaian tren pertumbuhan, apakah sesuai/mengikuti kurva pertumbuhan, mendatar atau memotong garis dibawahnya
- Target kenaikan berat badan balita minimal **5 gram/kgBB/hari** atau **50 gram/kgBB/minggu**

Misalnya Balita berat badan kurang mempunyai berat badan 8 kg,
maka target kenaikan berat badannya selama 1 minggu
 $= 50 \text{ gram} \times 8 \text{ kg} = 400 \text{ gram}$

ACUAN PELAKSANAAN PMT LOKAL 2026

Acuan Pelaksanaan Kegiatan PMT lokal melalui BOK Tahun 2026 antara lain:

- **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 119 Tahun 2025** tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
- **Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK01.07/MENKES/1180/2025** tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026
- **Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Nomor HK.02.02/B/567/2025** tentang Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil dan Balita Bermasalah Gizi



Dokumen terkait pelaksanaan PMT Berbahan Pangan Lokal lainnya dapat diakses melalui tautan berikut:

s.kemkes.go.id/OrientasiPMTLokal2026_3Angkatan

Acuan Pelaksanaan Kegiatan PMT lokal melalui BOK Tahun 2026 antara lain:



Daftar Isi

05	Daftar Isi
07	Penggunaan Buku
10	Pendahuluan
23	Mengenal Balita Bermasalah Gizi
35	PMT lokal bagi Balita Bermasalah Gizi
43	Kegiatan Kader dalam Pelaksanaan PMT lokal

Petunjuk teknis edisi ketiga tahun 2025 dalam Pelaksanaan Kegiatan PMT lokal tahun 2026

1. Alur deteksi dan tata laksana ibu hamil dengan **penambahan pemeriksaan oleh dokter pada ibu hamil bermasalah gizi.**
2. Alur deteksi dan tata laksana balita bermasalah gizi dengan pemeriksaan **oleh dokter; sasaran balita dengan atau tanpa stunting;** dan rujukan ke RS bagi balita tidak membaik setelah 2 minggu (14 hari) dan bagi balita stunting setelah 1 (satu) siklus PMT lokal untuk tatalaksana lanjutan stunting.
3. Komponen pembiayaan PMT lokal terdiri dari minimal 80% untuk belanja bahan dan maksimal 20% untuk penyelenggaraan PMT (upah memasak, biaya distribusi, dan manajemen)

Tahapan Penyelenggaraan PMT Berbahan Pangan Lokal

1 Perencanaan

- Penyusunan **Kerangka Acuan Pelaksanaan Kegiatan**
- Penetapan **Tim Pelaksana** Puskesmas
- Verifikasi dan **Penetapan Data Sasaran** Penerima PMT Berbahan Pangan Lokal
- Penetapan **Lokasi Kegiatan**
- Penyusunan **Siklus Menu** sesuai Standar
- Penyusunan **Rencana Anggaran** Kegiatan
- Penetapan **Metode Penyelenggaraan** PMT Berbahan Pangan Lokal

2 Persiapan dan Pelaksanaan

- **Pembekalan** Tim Pelaksana
- **Advokasi dan Koordinasi** dengan Desa/Kelurahan, PKK, Pihak Potensial Lainnya
- **Koordinasi Pembelian Bahan Makanan** Berbahan Pangan Lokal sesuai Siklus Menu
- **Koordinasi Pengolahan Bahan Makanan** sesuai dengan Siklus Menu
- **Koordinasi Distribusi** PMT Berbahan Pangan Lokal **disertai Edukasi** Integrasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor Terkait
- Penerapan **Protokol Kesehatan** untuk Pencegahan Penyakit
- Dalam penyediaan dan pelaksanaan PMT berbahan pangan lokal, puskesmas dapat bekerjasama dengan satuan pelayanan pemenuhan makanan bergizi di wilayah setempat, jika telah beroperasi (dengan catatan SPPG di wilayah masih mampu untuk mendukung penyediaan PMT berbahan pangan lokal)

3 Monitoring Evaluasi

- Koordinasi Pelaksanaan **Pemantauan Harian** oleh Kader
- Bersama Kader Melakukan **Pemantauan Mingguan**
- Koordinasi Pelaksanaan **Pemantauan Bulanan** untuk Perbaikan Penyelenggaraan PMT Berbahan Pangan Lokal
- Penyediaan **Formulir Pemantauan**
- Melakukan **Evaluasi** termasuk **Menganalisis Hasil Intervensi**

4 Pencatatan dan Pelaporan

- Melakukan **Pencatatan Berkesinambungan** terhadap Data Sasaran dan Keluaran antara lain *Input, Proses, Output* dan *Outcome*
- Melakukan **Pelaporan Berjenjang** terhadap Data Sasaran dan Keluaran antara lain *Input, Proses, Output* dan *Outcome*
- Pencatatan dan Pelaporan Dilakukan dari Tahap Penentuan Sasaran sampai dengan Berakhirnya Intervensi PMT Berbahan Pangan Lokal

Catatan:

- Daerah yang melaksanakan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan balita tetap melaksanakan PMT lokal bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi.
- **MBG menggantikan satu porsi makanan utama** untuk pemenuhan gizi. **PMT lokal diberikan sebagai tambahan** asupan harian tidak menggantikan makanan utama).
- Pada hari yang sama dengan pemberian MBG, **PMT lokal berupa makanan selingan/kudapan padat gizi**.

Pembiayaan

- Sumber pembiayaan kegiatan PMT berbahan pangan lokal dapat berasal dari berbagai sumber antara lain **APBN, Dana Transfer Daerah (DAK Non Fisik/BOK Puskesmas), APBD, Dana Desa, dan sumber pendanaan lainnya.**
- Dari pembiayaan berbagai sumber yang tersedia, pastikan semua sasaran Ibu hamil KEK dan risiko KEK serta Balita bermasalah gizi **100% mendapat PMT berbahan pangan lokal sesuai standar.**
- Darimana pun sumber pembiayaannya berasal, kegiatan PMT berbahan pangan lokal dilaksanakan dengan **mengacu Petunjuk Teknis dari Kementerian Kesehatan.**
- Pada prinsipnya kegiatan PMT berbahan pangan lokal **tidak diperkenankan adanya duplikasi anggaran** pada satu sasaran dengan waktu yang bersamaan.
Misalnya: seorang sasaran tidak diperkenankan mendapatkan PMT berbahan pangan lokal dari DAK NF/BOK Puskesmas dan Dana Desa pada satu waktu.
- **Besaran dan komponen biaya PMT berbahan pangan lokal disesuaikan dengan aturan yang berlaku yang menjadi dasar masing-masing sumber pembiayaan.**

PMT berbahan pangan lokal melalui **DAK NF/BOK Puskesmas**

- **Rincian kegiatan** dari menu PMT berbahan pangan lokal terdiri dari:
 1. Pembekalan Tim Pelaksana PMT berbahan pangan lokal
 2. Belanja Bahan PMT berbahan pangan lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Risiko KEK
 3. Belanja Bahan PMT berbahan pangan lokal bagi Balita Bermasalah Gizi
- **Komponen pembiayaan** terdiri dari:
 - ☐ Biaya bahan makanan dan bahan habis pakai lainnya **(minimal 80%)**
 - ☐ Biaya penyelenggaraan yaitu upah memasak, biaya distribusi, serta biaya manajemen **(maksimal 20%)**
- Daerah dapat mengusulkan **besaran unit cost PMT berbahan pangan lokal berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH)** yang berlaku di daerah masing-masing.



Administrasi

- o Ketentuan terkait pengelolaan DAK NF/BOK Puskesmas diatur tersendiri dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan melalui **Peraturan atau Keputusan Menteri Kesehatan**.
- o Ketentuan administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan PMT berbahan pangan lokal **mengacu pada peraturan yang dikeluarkan sehubungan dengan sumber pembiayaan yang digunakan**.

Misalnya: ketentuan administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan PMT berbahan pangan lokal melalui **DAK NF/BOK Puskesmas mengikuti ketentuan APBD**. Jadi termasuk mekanisme penyediaan, dapat dilakukan sesuai ketentuan daerah yang berlaku.

- o Ketentuan administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan PMT berbahan pangan lokal melalui DAK NF/BOK Puskesmas mengikuti mekanisme APBD sehingga penting **berkoordinasi dengan lintas sektor dan pemangku kebijakan di daerah** seperti Bappeda, Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Keuangan dan Anggaran, dll.

- o Sebagai pertanggungjawaban dan kelengkapan administrasi kegiatan, **harus disusun laporan yang dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan** (foto, video, dll). Ketentuan lebih lanjut terkait hal ini **mengikuti peraturan yang berlaku** yang dikeluarkan sehubungan dengan sumber pembiayaan yang digunakan.
- o **Ketentuan perpajakan** secara umum dapat mengacu pada peraturan terkait perpajakan yang berlaku secara nasional dan peraturan pajak daerah. Namun, karena perpajakan sifatnya kasuistik, maka dianjurkan dapat **berkonsultasi dengan kantor pajak wilayah setempat**.
- o Ketentuan terkait **mekanisme penyaluran anggaran** perlu dipahami oleh personalia pemegang program/penanggung jawab kegiatan PMT berbahan pangan lokal di Puskesmas maupun oleh bagian perencanaan dan keuangan.

Catatan:

Daerah dapat melengkapi dengan **petunjuk teknis turunan khususnya untuk aspek administrasi sebagai acuan detail pelaksanaan kegiatan PMT** berbahan pangan lokal di masing-masing daerah dengan **tetap mengacu** standar dan prinsip PMT lokal yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan regulasi/peraturan yang berlaku.



Pemantauan Kegiatan PMT Lokal

Waktu Pemantauan	Aspek yang Dipantau	Pelaksana Pemantauan
Pemantauan harian	1. Keterangan konsumsi PMT berbahan pangan lokal (dihabiskan atau tidak dihabiskan)	Kader
	2. Kondisi kesehatan Balita (sehat atau tidak sehat)	Kader
Pemantauan mingguan	1. Hasil penimbangan Berat Badan (BB) mingguan untuk sasaran Balita	Kader didampingi Tenaga Kesehatan
	2. Hasil pengukuran Panjang Badan/Tinggi Badan (PB/TB) mingguan untuk sasaran Balita	Kader didampingi Tenaga Kesehatan
Pemantauan bulanan	1. Hasil penimbangan Berat Badan (BB) bulanan dan penambahan BB untuk sasaran Ibu hamil	Kader didampingi Tenaga Kesehatan
	2. Aspek proses dan penyelenggaraan PMT lokal untuk perbaikan penyelenggaraan berikutnya	Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, Pusat

Catatan:

- Dokumentasi pemantauan kegiatan PMT berbahan pangan lokal harus dilakukan oleh Puskesmas.
- Pemantauan mingguan **diutamakan** dilakukan dengan pendampingan tenaga kesehatan.
- Tenaga Kesehatan memastikan kader dapat melakukan pengukuran antropometri sesuai standar.
- Pemantauan bulanan dilakukan untuk mengevaluasi proses kegiatan PMT lokal sehingga apabila ditemukan hambatan/kendala dapat segera dievaluasi

Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan dilakukan pada data awal dan aspek yang dipantau harian, mingguan, bulanan.

Hal-hal yang dicatat dan dilaporkan	Aspek/Keterangan
Hasil pemeriksaan awal	1. Ada atau tidaknya penyakit penyerta 2. Berat Badan (BB) awal 3. Panjang Badan atau Tinggi Badan (PB/TB) awal
Hasil pemantauan harian	1. Keterangan konsumsi PMT berbahan pangan lokal (dihabiskan atau tidak dihabiskan) 2. Kondisi kesehatan Balita (sehat atau tidak sehat)
Hasil pemantauan mingguan	1. Hasil penimbangan Berat Badan (BB) mingguan untuk sasaran balita 2. Hasil pengukuran Panjang Badan/Tinggi Badan (PB/TB) mingguan untuk sasaran balita
Hasil pemantauan bulanan	1. Hasil penimbangan Berat Badan (BB) bulanan dan penambahan BB untuk sasaran Ibu hamil 2. Aspek proses dan penyelenggaraan PMT berbahan pangan lokal untuk perbaikan penyelenggaraan berikutnya

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Pusat. Pencatatan pelaporan juga dapat dipantau *real time* secara otomatis melalui aplikasi Sistem Informasi yang berlaku .

Kriteria *Drop Out*

Sasaran kegiatan PMT berbahan pangan lokal dapat gagal/*drop out* jika sasaran penerima PMT berbahan pangan lokal tidak secara penuh mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PMT berbahan pangan lokal, yaitu apabila:

- Orang tua/keluarga **menolak/mengundurkan diri**
- Sasaran **tidak mendapatkan PMT berbahan pangan lokal** selama **kurun waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut** (misalnya pergi ke luar daerah, pindah domisili, dll)
- Sasaran sakit dan dirawat di RS (perlu mendapatkan tata laksana lain)
- Sasaran meninggal
- Pada sasaran Ibu hamil KEK dan risiko KEK, telah melahirkan atau keguguran

Catatan:

Anggaran sisa sasaran yang *drop out* dapat **dimanfaatkan untuk penambahan sasaran atau melanjutkan intervensi PMT berbahan pangan lokal pada sasaran lainnya**

Anggaran sisa sasaran yang *drop out* dianjurkan untuk dimanfaatkan

Mencegah Sasaran *Drop Out*

- Lakukan kegiatan **sosialisasi** secara luas kepada masyarakat sebelum mulai kegiatan PMT berbahan pangan lokal
- Pastikan sebelum pelaksanaan kegiatan PMT berbahan pangan lokal, **periksa ulang status gizi dan kesehatan sasaran**
- Pastikan keluarga sasaran **bersedia** untuk menjadi sasaran kegiatan dan mengikuti secara penuh (dapat ditanyakan secara lisan)
- Tenaga Kesehatan dan Kader **responsif** terhadap semua keluhan sasaran (rasa makanan, menu disukai atau tidak, penampilan makanan, dll)
- Tenaga Kesehatan dan Kader bersama lintas sektor terkait segera **menindaklanjuti sasaran yang susah ditemui**
- Jika tersedia anggaran, berikan **apresiasi** kepada sasaran yang mempunyai praktik baik (ucapan, sertifikat, dll)
- Apabila sasaran berpindah domisili, Puskesmas dapat **berkoordinasi** dengan Puskesmas wilayah kerja domisili baru

Pemberian PMT perlu disertai dengan **edukasi gizi dan kesehatan** bagi Ibu dan Balita bermasalah gizi



• **Konseling gizi**

Memastikan **peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku** pada ibu hamil dan ibu balita serta pengasuh agar dapat menerapkan pola makan sesuai prinsip gizi seimbang sesuai kondisi dan kebutuhannya

Konseling gizi dilakukan secara individual melalui komunikasi interpersonal



• **Penyuluhan gizi**

Dilakukan di kelompok kecil, bersamaan dengan pelaksanaan PMT berbahan pangan lokal dan dapat dilakukan bersamaan dengan jadwal posyandu atau kegiatan masyarakat lainnya

Penyuluhan dilakukan antara **15 – 30 menit di Posyandu atau tempat lain yang disepakati**

Penyuluhan dapat diintegrasikan dengan forum yang tersedia seperti Kelas Ibu Balita, Kelas Ibu Hamil, dll)

Materi penyuluhan terkait dengan **kebutuhan gizi, pemilihan pangan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, stimulasi perkembangan dan kesehatan balita**



• **Demonstrasi masak**

Bertujuan agar Ibu hamil dan orang tua/pengasuh Balita sasaran memperoleh **keterampilan dalam memilih, menyiapkan, dan mengolah makanan** untuk dikonsumsi setiap hari

Demo masak **dapat dilaksanakan** agar sasaran memperoleh pengetahuan tentang aspek gizi dan kesehatan pada Balita dan Ibu hamil

Peralatan memasak dan bahan makanan berbasis pangan lokal untuk demo masak disiapkan oleh tim pelaksana tingkat Desa/Kelurahan

